

風專筆試複習 30 題 — 20260513

依 2019–2024 六年考古題出題比例選題 (~600 題統計)

基礎免疫學 (2 題)

Q1 (2022 考古)

關於 T 細胞亞群與其主要分泌細胞激素的配對，以下何者**錯誤**？

- A. Th1 → IFN- γ
- B. Th2 → IL-4
- C. Tfh → IL-17
- D. Treg → TGF- β

Q2 (2024 考古)

下列哪個細胞激素**不會**透過 JAK1 / JAK2 訊號路徑進行傳遞？

- A. IL-2
- B. IL-5
- C. TNF- α
- D. IL-10

SLE / Lupus Nephritis / APS (3 題)

Q3 (2023 考古)

20 歲女性，出現發燒、WBC 2,500/ μ L、Hb 8 g/dL（直接 Coombs 試驗陽性）、血小板 8,000/ μ L，其餘檢查皆正常。依 2019 ACR/EULAR SLE 分類標準，以下何者**正確**？

- A. 13 分，符合 SLE 診斷標準
- B. 13 分，不符合 SLE 診斷標準
- C. 6 分，符合 SLE 診斷標準
- D. 6 分，不符合 SLE 診斷標準

Q4 (2024 考古)

關於狼瘡性腎炎（Lupus Nephritis），以下何者**正確**？

- A. 若每日蛋白尿達 0.5 g，不需腎切片即可直接分類
- B. 尿液檢查不一定出現血尿或管型（cast）
- C. Class IV LN 定義為超過 50% 腎小球出現瀰漫性病變（diffuse）
- D. Creatinine 是追蹤 LN 活性最可靠的指標

Q5 (2024 考古)

40 歲女性，SLE 多年，長期使用類固醇 10–40 mg/d，一個月內漸進性呼吸困難，理學檢查 P2 亢進、雙側下肢水腫，後突然猝死。以下何項最可能是導致猝死的原因？

- A. 心臟超音波顯示 RVSP 60 mmHg（符合重度肺高壓）
- B. HRCT 顯示肺間質纖維化

- C. UPCR 20 g/g
- D. Anti-ribosomal P 抗體陽性

SpA / AS / PsA (3 題)

Q6 (2024 考古)

關於中軸型脊椎關節炎 (Axial SpA)，以下何者**錯誤**？

- A. 不建議以全身性類固醇作為主要治療
- B. mSASS 評分宜每年追蹤
- C. 可使用 BASFI 評估疾病活性程度
- D. NSAID 是中軸 SpA 的首選藥物治療

Q7 (2024 考古)

中年男性，診斷乾癬性關節炎 (PsA)，且有長期抽菸史，請問以下何種生物製劑**最適合**？

- A. TNFi (如 adalimumab)
- B. IL-17i (如 secukinumab)
- C. IL-23i (如 guselkumab)
- D. JAKi (如 tofacitinib)

Q8 (2021/2023 考古)

關於脊椎關節炎 (SpA) 的診斷特徵，以下何者**不是** SpA 的典型表現？

- A. 炎性下背痛 (inflammatory back pain)
- B. HLA-B27 陽性
- C. 服用 NSAID 後症狀顯著改善
- D. 服用 NSAID 後症狀**無明顯反應**

類風濕性關節炎 (RA) (3 題)

Q9 (2023 考古)

Carbamylated protein 的 post-translational modification，是將哪個胺基酸轉化為哪個胺基酸？

- A. Arginine → Citrulline
- B. Lysine → Homocitrulline
- C. Glutamine → Asparagine
- D. Tyrosine → Phosphotyrosine

Q10 (2023 考古)

一位 RA 患者，血清 Creatinine 1.6 mg/dL，下列哪種 DMARD 最**不適合**使用？

- A. Leflunomide
- B. Methotrexate (MTX)
- C. 低劑量類固醇 (Glucocorticoids)

D. TNF 抑制劑

Q11 (2020 考古)

RA 患者頸椎 atlanto-axial joint subluxation 的定義，以下何者**正確**？

- A. 頸椎屈曲 (flexion) 時 C1–C2 前間距 > 3 mm
 - B. 頸椎屈曲時 C1–C2 前間距 > 10 mm
 - C. 頸椎伸展 (extension) 時 C1–C2 前間距 > 3 mm
 - D. 靜止直立位時 C1–C2 前間距 > 5 mm
-

藥物學 (3 題)

Q12 (2020/2023 考古)

以下生物製劑與其作用機轉的配對，何者**有誤**？

- A. Denosumab — anti-RANK
 - B. Tocilizumab — anti-IL-6 receptor
 - C. Dupilumab — anti-IL-4R α
 - D. Etanercept — TNF receptor fusion protein
-

Q13 (2024 考古)

關於藥物與眼部副作用的配對，以下何者**錯誤**？

- A. Hydroxychloroquine → retinal maculopathy
 - B. Adalimumab → 造成葡萄膜炎 (uveitis)
 - C. Dupilumab → conjunctivitis (結膜炎)
 - D. Cevimeline → 可能加重青光眼
-

Q14 (2020/2022 考古)

針對 Fibromyalgia 的藥物治療，以下何者**不屬於** Level I A 等級的推薦用藥？

- A. Gabapentin / Pregabalin
 - B. SSRI (如 fluoxetine)
 - C. Opioid (如 tramadol)
 - D. TCA (如 amitriptyline)
-

發炎性肌病 (IIM) (3 題)

Q15 (2024 考古)

關於 Anti-MDA5 antibody，以下敘述何者**不正確**？

- A. 臨床上常有典型、明顯的肌肉無力症狀
- B. 臨床常伴有皮膚潰瘍 (cutaneous ulcerations) 與掌面紅斑 (palmar erythema)
- C. 在亞洲族群中，陽性者與 rapidly progressive ILD (RP-ILD) 有關
- D. 血中 ferritin 升高代表預後較差

Q16 (2024 考古)

關於各類 IIM 的肌肉切片特徵，以下何者**錯誤**？

- A. Dermatomyositis (DM)：主要浸潤細胞為 CD4+ T cells，可見 perifascicular atrophy
- B. Polymyositis (PM)：主要浸潤細胞為 CD8+ T cells，侵入正常肌纖維
- C. Inclusion body myositis (IBM)：可見 rimmed vacuoles
- D. DM：主要浸潤細胞為 **CD8+ T cells**

Q17 (2024 考古)

關於 2017 EULAR/ACR IIM 分類標準，以下何者**為非**？

- A. 症狀發作年齡 ≥ 40 歲（作為分類標準計分項目）
- B. 頸部屈肌（neck flexors）相對弱於頸部伸肌（neck extensors）
- C. Gottron papules
- D. 肌肉切片出現 rimmed vacuoles（IBM 特徵，不計入 IIM 共同標準得分）

全身性硬化症（SSc）（2 題）

Q18 (2024 考古)

35 歲女性出現雷諾氏現象（Raynaud's phenomenon），以下何者**不支持**繼發性（secondary）RP 的診斷？

- A. 年齡 > 35 歲
- B. 雙側對稱性發作（bilateral symmetric involvement）
- C. 合併指尖潰瘍（digital pitting ulcer）
- D. 四季皆有發作

Q19 (2023 考古)

關於 SSc 合併肺高壓（SSc-PAH）的篩查，以下何者**錯誤**？

- A. DLCO $< 55\%$ 是篩查 PAH 的重要指標之一
- B. Anti-centromere Ab（ACA）、Anti-Th/To、Anti-U3-RNP 與 SSc-PAH 風險相關
- C. 右心導管 mean PAP ≥ 20 mmHg 且 PCWP ≤ 15 mmHg 可確診 PAH
- D. DLCO $< 80\%$ 即需積極安排右心導管確診 PAH

血管炎（2 題）

Q20 (2024 考古)

關於血管炎疾病特徵，以下哪種組合**正確**？

- (1) GPA $\rightarrow$ c-ANCA (+)
- (2) Henoch-Schönlein Purpura $\rightarrow$ elevated IgE
- (3) Polyarteritis nodosa $\rightarrow$ paranasal sinusitis
- (4) Takayasu's arteritis $\rightarrow$ pulseless disease

- (5) Leukocytoclastic vasculitis → p-ANCA (+)
(6) EGPA (Churg-Strauss) → allergic disorder
(7) Giant cell arteritis → elevated IgA

- A. 1 + 4 + 6
B. 1 + 2 + 3
C. 2 + 6 + 7
D. 3 + 5 + 7

Q21 (2024 考古)

關於 AAV 維持治療，以下何者**錯誤**？

- A. MAINRITSAN 試驗顯示 RTX 維持治療的 sustained remission 率**優於** Azathioprine
B. Avacopan 是 C5a receptor antagonist，可輔助 GPA/MPA 治療
C. MAINRITSAN 試驗中 RTX 維持組的 sustained remission 率**低於** AZA 組
D. Cyclophosphamide 與 Rituximab 均可用於 AAV 的 induction 治療

痛風 / 晶體關節炎 (2 題)

Q22 (2024 考古)

關於鈣焦磷酸沉積症 (CPPD)，以下何者**正確**？

- A. 好發於中年肥胖男性，發作模式類似痛風
B. 偏振光顯微鏡下呈 **strong negative birefringence**
C. 結晶外觀為菱形 (rhomboid)，呈 **strong positive birefringence**；與 hyperparathyroidism 等鈣代謝異常有關
D. 與嘌呤代謝異常 (hyperuricemia) 密切相關

Q23 (2024 考古)

一位 45 歲男性，有 SLE、APS 及 Gout 病史，eGFR 45 mL/min，有泌尿道結石及 allopurinol 過敏史。關於降尿酸藥物選擇，以下何者**正確**？

- A. Febuxostat 為首選，且可安心與 Azathioprine 合用
B. Febuxostat 與 Warfarin 有交互作用，容易造成 Warfarin 過量
C. Pegloticase 為 recombinant uricase，使用前需注意病人是否有 G6PD 缺乏
D. Probenecid 適用於腎功能不全且有腎結石的患者，每日劑量約 3,000–4,000 mg

超音波影像 (2 題)

Q24 (2023 考古)

關於肌肉骨骼超音波評估 MCP/PIP 關節，以下何者**正確**？

- A. 建議使用 7.5 MHz 低頻探頭
B. 受檢手指應採握拳姿勢 (fist position)
C. 探頭與皮膚之間應保留耦合凝膠 (coupling gel) 以避免 acoustic artifact
D. 若 dorsal view 正常，即無需再做 palmar view 評估

Q25 (2021/2024 考古)

關於 RA 超音波評估，以下何者**正確**？

- A. Power Doppler (PD) 信號可評估滑膜血管增生，但無法輔助減藥決策
 - B. 臨床緩解 (clinical remission) 時超音波必然無異常發現
 - C. 超音波可偵測 clinical remission 時仍存在的 subclinical synovitis，有助於預測復發及指導減藥
 - D. MCP 關節超音波應使用 3–5 MHz 低頻探頭
-

骨質疏鬆 (1 題)

Q26 (2021 考古)

關於糖皮質固醇誘發骨質疏鬆症 (GIOP) 的治療，以下何者**正確**？

- A. Bisphosphonate 為大多數患者的第一線治療
 - B. Denosumab 停藥後不需銜接其他骨質疏鬆藥物
 - C. Teriparatide 適合低骨折風險的患者作為初始治療
 - D. SERM (如 Raloxifene) 常造成顎骨壞死 (ONJ)，需謹慎使用
-

Fibromyalgia (1 題)

Q27 (2024 考古)

關於纖維肌痛症 (Fibromyalgia, FM)，以下何者**錯誤**？

- A. 風濕免疫疾病 (RMD) 患者合併 FM 的比例高於一般族群
 - B. RMD 患者若同時有 FM，疾病活性評估的準確性較差
 - C. FM 患者對重壓 (heavy pressure) 感到疼痛，但對輕觸 (light touch) 不會感到疼痛
 - D. FM 患者即便降低局部炎症活性，也不能完全改善全身性疼痛症狀
-

骨關節炎 / 復健 (1 題)

Q28 (2024 考古)

下列針對骨關節炎 (OA) 的治療，目前有**最多實證支持** (evidence-based) 者為何？

- A. 完全關節休息、避免承重活動
 - B. 超音波熱療
 - C. 肌力訓練 (strengthening exercise)
 - D. 關節腔玻尿酸注射
-

乾燥症 (Sjogren's Syndrome) (1 題)

Q29 (2024 考古)

關於乾燥症唇腺切片 (labial salivary gland biopsy) 的病理表現，以下何者**錯誤**？

- A. 主要浸潤細胞以 CD4+ T cells 及 B cells 為主
- B. 主要浸潤細胞以 CD8+ T cells 及 B cells 為主
- C. 少數浸潤細胞可見 Plasma cells
- D. 少數浸潤細胞可見 Natural killer cells

SLE — Neonatal Lupus (1 題)

Q30 (2022 考古)

關於 Neonatal Lupus 與先天性心臟傳導阻斷 (Congenital Heart Block, CHB)，以下何者正確？

- A. 母親 SSA/Ro 抗體陽性者，子女發生 CHB 的機率約為 20–25%
- B. 母親有 SSA/SSB 抗體陽性者，新生兒狼瘡的發生率約為 2%
- C. 確診第三度 CHB 後，靜脈類固醇可完全逆轉心臟傳導異常
- D. 曾生過 CHB 寶寶的母親，再次懷孕時複發率 < 5%

✓ 解答 & 重點解析

題號	答案	核心考點
Q1	C	Tfh → IL-21 (非 IL-17)；IL-17 是 Th17 分泌
Q2	C	TNF-α 走 TRAF/NFκB，不走 JAK-STAT
Q3	D	Fever 2 分 + Autoimmune hemolysis 4 分 = 6 分，需 ≥10 分才符合標準
Q4	B	LN 尿沉渣可以正常，不一定有血尿或管型
Q5	A	RVSP 60 mmHg = 重度 PAH，是突發猝死最可能原因
Q6	C	BASFI 評估 功能 ，不是疾病活性；ASDAS/BASDAI 才是活性評估
Q7	B	PsA + 抽菸 (CV risk) → 避免 JAKi；IL-17i 為適合選擇
Q8	D	SpA 特徵是對 NSAID 有反應 ；無反應不是典型表現
Q9	B	Carbamylation：Lysine → Homocitrulline ；ACPA：Arginine → Citrulline
Q10	B	MTX 經腎排泄，Cr > 1.6 mg/dL 需避免使用
Q11	A	Atlanto-axial subluxation：flexion 時前間距 > 3 mm
Q12	A	Denosumab 靶點是 RANKL ，不是 RANK 本身
Q13	B	Adalimumab (TNFi) 實際上是 治療 uveitis，不是造成
Q14	C	Opioid 不是 FM 的 Level IA 用藥；TCA/SNRI/Pregabalin 才是
Q15	A	Anti-MDA5 → amyopathic DM，肌肉無力往往 輕微或缺乏
Q16	D	DM 主要浸潤細胞是 CD4+ (非 CD8+)，合併 perifascicular atrophy
Q17	A	2017 EULAR/ACR IIM 標準中，age ≥40 years 不是單獨計分項目
Q18	B	雙側對稱 發作 = primary RP 的特徵；secondary RP 常為不對稱
Q19	D	SSc-PAH 篩查切點：DLCO < 55% (非 <80%)

題號	答案	核心考點
Q20	A	正確：(1)GPA→cANCA ✓ (4)Takayasu→pulseless ✓ (6)EGPA→allergic ✓
Q21	C	MAINRITSAN：RTX 維持治療優於 AZA，C 的說法相反故錯誤
Q22	C	CPPD：rhomboïd shape， strong positive birefringence；與鈣代謝異常相關
Q23	C	Pegloticase 使用前須篩查 G6PD 缺乏 （可引發溶血）
Q24	C	探頭與皮膚間需耦合凝膠；需雙側 dorsal + palmar view
Q25	C	超音波可偵測 subclinical synovitis，指導減藥決策
Q26	A	GIOP 第一線 = Bisphosphonate ；高骨折風險→Teriparatide；Denosumab 停藥需銜接 BP；SERM 不造成 ONJ
Q27	C	FM 有 allodynia ，輕觸也會引發疼痛（非「輕觸不會痛」）
Q28	C	肌力訓練是 OA 唯一有強力 evidence 支持的非藥物治療
Q29	B	SjS 唇腺切片主要是 CD4+ T cells 和 B cells，不是 CD8+
Q30	B	Neonatal lupus CHB 發生率約 2% （母親 SSA/SSB(+)）；複發率 18–20%

⚡ 高頻陷阱速查

陷阱	正確答案
Tfh 分泌何種 cytokine？	IL-21 （非 IL-17）
TNF-α 走 JAK-STAT 嗎？	不走，走 TRAF/NFκB
BASFI 評估什麼？	功能 （非疾病活性）
Denosumab 靶點？	RANKL （非 RANK）
Adalimumab 與 uveitis 關係？	治療 uveitis （非造成）
DM 肌肉切片主要細胞？	CD4+ （非 CD8+）
Bilateral symmetric RP →？	Primary RP （非 secondary）
SSc-PAH 篩查 DLCO 切點？	< 55% （非 <80%）
CPPD birefringence？	Strong positive （MSU 為 strong negative）
Neonatal lupus CHB 發生率？	2% ，複發率 18–20%
FM 對輕觸有無反應？	有 （allodynia，輕觸即可引發疼痛）
Opioid 是 FM 的 IA 用藥嗎？	否 （TCA/SNRI/Pregabalin 才是）
mSASS 滿分？	72 分
ACPA vs Carbamylated protein 修飾？	ACPA：Arg→Citrulline；Carbamyl： Lys→Homocitrulline